

Fac-simile di documentazione clinica per la didattica

Raccolta di documenti fittizi in ambito internistico per esercitarsi a riconoscere dove nasce un’informazione, come cambia nel tempo e in quale documento viene comunicata al professionista successivo.

Tutti i casi sono inventati. Le lettere A, B e C sono solo codici didattici; non compaiono nomi, date di nascita, recapiti, ospedali o identificativi reali. Date, dosi e risultati sono costruiti per la simulazione e non costituiscono indicazioni per pazienti reali.

Come leggere la raccolta

Caso	Percorso	Documenti presenti
A	PS → Medicina interna → domicilio	Verbale PS con ricovero, anamnesi remota e prossima, esame obiettivo, ECG, laboratorio, angio-TC, terapia, quattro note di diario, lettera di dimissione.
B	PS → domicilio	Verbale di accesso in PS concluso con dimissione.
C	Ambulatorio → follow-up	Referto di visita diabetologica con terapia e controlli programmati.

Nei documenti del caso A l’ordine di presentazione raggruppa i tipi di documento. Gli orari riportati nei singoli atti permettono di ricostruire la sequenza effettiva. Un’indicazione “prescritta” non equivale, da sola, a una somministrazione avvenuta.

Riferimenti usati per la plausibilità degli esempi

Ministero della Salute, Il flusso informativo SDO e Fascicolo sanitario elettronico; NICE, Pneumonia: diagnosis and management (NG250, 2025); American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes 2026, sezioni 13 e 16. Struttura dei documenti e schemi clinici sono esemplificativi e possono variare secondo il contesto e i protocolli locali.

Caso A Ricovero in Medicina interna

Donna, 74 anni | Episodio dal 10 al 14 settembre 2026 | Polmonite acquisita in comunità

A1 Verbale di pronto soccorso con disposizione di ricovero

Ingresso 10/09/2026 ore 08:42 | Chiusura verbale ore 13:20 | Estensore: medico di PS

Motivo di accesso: Dispnea e febbre da circa tre giorni, tosse produttiva. Dalla mattina dolore toracico destro accentuato dall'inspirazione. Non emottisi. A domicilio nessuna terapia antibiotica.

Triage e parametri: Ore 08:50: temperatura 38,2 °C; PA 104/65 mmHg; FC 108/min; FR 26/min; SpO₂ 89% in aria ambiente. Vigile, orientata. Assegnata area di valutazione urgente.

Valutazione e interventi: Ossigeno con cannule nasali a 2 L/min, con SpO₂ 94%. Prelievi ematici ed ECG richiesti. Angio-TC torace richiesta per ipossiemia, tachicardia e dolore pleuritico, allo scopo di valutare anche l'ipotesi di embolia polmonare.

Accertamenti acquisiti: ECG: tachicardia sinusale, nessun segno di ischemia acuta. Leucociti $14,8 \times 10^9/L$, PCR 137 mg/L, creatinina 1,42 mg/dL (riferita abituale circa 1,10), D-dimero 1,35 mg/L FEU. Angio-TC: nessuna embolia polmonare fino ai rami segmentari; consolidamento del lobo inferiore destro compatibile con polmonite nel contesto clinico.

Valutazione conclusiva: Polmonite acquisita in comunità con insufficienza respiratoria ipossiêmica; incremento acuto della creatinina in corso di ridotto introito idrico. Necessità di ossigeno e di osservazione clinica.

Esito e passaggio di consegne: Ore 13:20: disposto ricovero in Medicina interna. Trasferimento in reparto alle 14:05. Consegnati verbalmente necessità di ossigeno e controllo della funzione renale.

A2 Anamnesi patologica remota in cartella clinica

Registrata il 10/09/2026 ore 14:32 | Estensore: medico di reparto | Fonte: paziente e terapia domiciliare riferita

Patologie note: Ipertensione arteriosa da circa 15 anni; malattia renale cronica G3a nota, creatinina abituale intorno a 1,10 mg/dL nei controlli ambulatoriali; artrosi del ginocchio destro. Nessuna pregressa tromboembolia venosa. Nessun ricovero nell'ultimo anno.

Terapia domiciliare: Ramipril 5 mg per os ogni mattina. Paracetamolo assunto occasionalmente per dolore osteoarticolare. La lista dei farmaci è riferita dalla paziente e sarà riconciliata con le confezioni disponibili.

Altri elementi rilevanti: Non riferite allergie a farmaci note. Non fumatrice; autonomia nelle attività quotidiane di base; vive con il coniuge.

A3 Anamnesi patologica prossima in cartella clinica

Registrata il 10/09/2026 ore 14:39 | Estensore: medico di reparto

Dal 7 settembre comparsa di febbre fino a 38,5 °C, tosse dapprima secca poi con espettorato giallastro, progressiva astenia e dispnea per sforzi abituali. Nelle ultime 24 ore ridotti alimentazione e introito di liquidi. La mattina dell'accesso compare dolore puntorio alla base del

torace destro durante l'inspirazione profonda. Non riferisce sintomi urinari, emottisi o edema degli arti inferiori.

In PS sono stati documentati ipossiemia in aria ambiente, indici di flogosi elevati, consolidamento polmonare destro alla TC e assenza di embolia polmonare nei rami valutabili. La paziente è stata trasferita in reparto con ossigeno a 2 L/min.

A4 Esame obiettivo di ingresso in cartella clinica

Eseguito il 10/09/2026 ore 14:45 | Estensore: medico di reparto

PA 112/68 mmHg, FC 99/min, FR 23/min, temperatura 37,9 °C, SpO₂ 94% con O₂ 2 L/min. Vigile, orientata, collaborante. Mucose lievemente asciutte.

Torace: ridotta espansione della base destra, crepitii inspiratori in sede basale destra; nessun sibilo diffuso. Cuore: toni ritmici, tachicardici, soffi non apprezzabili. Addome trattabile, non dolente. Arti inferiori: assenza di edema e di segni clinici di trombosi venosa profonda. Diuresi riferita ridotta nelle ultime 24 ore.

Sintesi: Impressione iniziale: quadro respiratorio coerente con polmonite basale destra; rivalutare ossigenazione, idratazione e creatinina.

A5 Referto ECG a 12 derivazioni

Acquisito in PS il 10/09/2026 ore 09:46 | Refertato ore 09:53 | Referto testuale, tracciato non incluso

Indicazione: tachicardia e dispnea con dolore toracico pleuritico. Ritmo sinusale a 106/min. Asse elettrico nei limiti. PR 158 ms, QRS 88 ms, QTc 421 ms. Nessuna alterazione ST-T suggestiva di ischemia acuta. Nessun segno elettrocardiografico specifico di sovraccarico ventricolare destro.

Conclusione: Tachicardia sinusale. Interpretare nel contesto clinico; l'ECG da solo non esclude un'embolia polmonare.

A6 Referto di laboratorio

Prelievo 10/09/2026 ore 09:18 | Validazione ore 10:24 | Intervalli di riferimento del laboratorio simulato

Esame	Risultato	Unità	Intervallo
Leucociti	14,8 ↑	×10 ⁹ /L	4,0–10,0
Neutrofili	12,6 ↑	×10 ⁹ /L	1,8–7,5
Emoglobina	12,1	g/dL	12,0–16,0
Piastrine	275	×10 ⁹ /L	150–400
PCR	137 ↑	mg/L	<5
Creatinina	1,42 ↑	mg/dL	0,55–1,02
eGFR CKD-EPI	38 ↓	mL/min/1,73 m ²	≥60
Azotemia	54 ↑	mg/dL	15–50

Esame	Risultato	Unità	Intervallo
Sodio	133 ↓	mmol/L	135–145
Potassio	4,2	mmol/L	3,5–5,1
Glicemia	134 ↑	mg/dL	70–99 a digiuno
D-dimero	1,35 ↑	mg/L FEU	<0,50

Nota di refertazione: Il valore di eGFR è stimato sulla creatinina del prelievo acuto. D-dimero richiesto nell’iter per sospetta embolia polmonare: l’aumento è aspecifico e non formula da solo una diagnosi.

A7 Referto angio-TC torace

Richiesta da PS il 10/09/2026 ore 10:35 | Esame ore 11:24 | Referto validato ore 12:04

Quesito clinico: Dispnea, ipossiemia, tachicardia e dolore toracico pleuritico; valutazione di possibile embolia polmonare.

Tecnica: Angio-TC del torace dopo somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto, con acquisizioni nella fase arteriosa polmonare. Qualità diagnostica adeguata fino ai rami segmentari.

Reperti: Non difetti di riempimento delle arterie polmonari principali, lobari o segmentarie. Consolidamento parenchimale del segmento basale posteriore del lobo inferiore destro con broncogramma aereo. Minimo ispessimento pleurico adiacente; non versamento pleurico significativo. Non altri addensamenti focali. Vie aeree centrali pervie.

Conclusioni: Assenza di embolia polmonare nei rami valutabili. Addensamento del lobo inferiore destro compatibile con processo flogistico infettivo nel contesto clinico.

A8 Foglio di terapia durante il ricovero

Ordini dal 10/09/2026 ore 15:25 | Prescrittore: medico di reparto | Aggiornamenti datati nelle righe

Prescrizione	Modalità	Decorrenza e modifica
Ceftriaxone	2 g EV ogni 24 ore, ore 16	10/09–14/09; rivalutazione quotidiana
Azitromicina	500 mg per os ogni 24 ore, ore 17	10/09–12/09; conclusa dopo terza dose
Enoxaparina	4.000 UI SC ogni 24 ore, ore 20	10/09–13/09; profilassi durante degenza
Ossigeno	Cannule nasali 2 L/min; titolare per SpO ₂ ≥92%	10/09; 1 L/min dal 12/09 ore 09; sospeso 13/09 ore 09
NaCl 0,9%	500 mL EV in 4 ore	10/09 ore 16–20; singola prescrizione
Ramipril	5 mg per os ore 08	Domiciliare; temporaneamente sospeso 10–12/09; ripreso 13/09
Paracetamolo 1 g	Per os se febbre o dolore	Dal 10/09; al bisogno, max 3 g/die

Somministrazioni documentate: Estratto del registro delle somministrazioni. Gli orari sono registrazioni di esecuzione; il trattino significa che non era prevista una dose in quella data.

Terapia	10/09	11/09	12/09	13/09	14/09
Ceftriaxone	16:12	16:03	16:08	16:05	16:02
Azitromicina	17:10	17:04	17:06	—	—
Enoxaparina	20:01	20:12	20:04	20:07	—
Ramipril	Sosp.	Sosp.	Sosp.	08:10	08:04
Paracetamolo al bisogno	19:14	—	—	—	—

NaCl 0,9%: infusione iniziata il 10/09 alle 16:20 e terminata alle 20:20. Ossigeno: somministrazione continuativa registrata nel monitoraggio infermieristico, con riduzione e sospensione secondo le prescrizioni sopra riportate.

A9 Diario clinico quattro note

Cartella di reparto | Voci riportate nell'ordine di registrazione

Nota 1 11/09/2026 ore 09:10

Persistono tosse e lieve dispnea nel passaggio letto-poltrona. T 37,8 °C, PA 118/70 mmHg, FC 91/min, FR 21/min, SpO₂ 95% con O₂ 2 L/min. Crepitii basali destri. Diuresi ripresa; idratazione orale migliorata. Controllo odierno: PCR 102 mg/L, creatinina 1,30 mg/dL. Proseguire antibiotici e O₂; ramipril ancora sospeso. Ricontrollare funzione renale e necessità di O₂ domani. | Medico di reparto

Nota 2 12/09/2026 ore 09:05

Apiretica da oltre 24 ore, ridotta dispnea. T 36,8 °C, FC 84/min, FR 19/min, SpO₂ 95% con O₂ 2 L/min; prova a 1 L/min con SpO₂ 94%. PCR 64 mg/L, creatinina 1,16 mg/dL, Na 136 mmol/L. Ridotto O₂ a 1 L/min; mantenere terapia antibiotica; rivalutare sospensione dell'ossigeno domani. Ultima dose programmata di azitromicina oggi. | Medico di reparto

Nota 3 13/09/2026 ore 09:20

Cammina in corridoio senza dispnea rilevante. T 36,7 °C, PA 126/74 mmHg, FC 78/min, FR 18/min; SpO₂ 95% in aria ambiente dopo sospensione O₂ alle 09:00, 93% dopo breve cammino. Creatinina in miglioramento; riprende ramipril 5 mg alle 08:10, con controllo pressorio e funzione renale. Proseguire ceftriaxone fino al completamento del ciclo previsto; non proseguire azitromicina. Possibile dimissione domani se stabilità confermata. | Medico di reparto

Nota 4 14/09/2026 ore 09:30

Asintomatica a riposo; tosse residua modesta. T 36,6 °C, PA 124/72 mmHg, FC 76/min, FR 17/min, SpO₂ 95% in aria ambiente. Leucociti 8,7 ×10⁹/L, PCR 25 mg/L, creatinina 1,10 mg/dL, K 4,3 mmol/L. Confermato completamento del quinto giorno di ceftriaxone alle ore 16, poi dimissione a domicilio. Preparata lettera per MMG con indicazione di ricontrollare creatinina ed elettroliti entro una settimana. | Medico di reparto

A10 Lettera di dimissione da Medicina interna

Redatta il 14/09/2026 ore 16:40 | Dimissione ore 17:10 | Destinatario: medico di medicina generale

Diagnosi alla dimissione: Ricovero dal 10 al 14 settembre 2026 per polmonite acquisita in comunità del lobo inferiore destro con ipossiemia, associata a temporaneo peggioramento della funzione renale in corso di ridotto introito idrico.

Motivo del ricovero e accertamenti: Ingresso dal PS per febbre, tosse e dispnea; SpO₂ iniziale 89% in aria ambiente. Gli esami mostravano PCR 137 mg/L, leucocitosi e creatinina 1,42 mg/dL (basale riferita circa 1,10). L'angio-TC del 10/09 ha escluso embolia polmonare nei rami valutabili e ha evidenziato consolidamento basale destro.

Decorso e trattamenti: Trattata con ceftriaxone EV dal 10 al 14/09 (ultima dose somministrata alle 16:02 del 14/09) e azitromicina per os dal 10 al 12/09. Ossigeno nasale dal 10 al 13/09, poi mantenuta saturazione ≥95% a riposo in aria ambiente. Idratazione EV limitata al giorno di ingresso e poi per os. Ramipril sospeso temporaneamente per peggioramento della funzione renale e ripreso il 13/09 dopo miglioramento. Profilassi tromboembolica durante la degenza.

Condizioni alla dimissione: Apiretica e clinicamente stabile; PA 124/72 mmHg, FC 76/min, FR 17/min, SpO₂ 95% in aria ambiente. Leucociti 8,7 ×10⁹/L, PCR 25 mg/L, creatinina 1,10 mg/dL, K 4,3 mmol/L.

Terapia alla dimissione: Ramipril 5 mg per os al mattino. Il ciclo antibiotico si è concluso in ospedale: nessun antibiotico da assumere a domicilio. Non prescritta ossigenoterapia domiciliare.

Follow-up e indicazioni: Valutazione dal MMG entro 5–7 giorni, con controllo di creatinina e potassio entro una settimana dopo la ripresa del ramipril. Rivalutazione clinica se febbre ricorrente, peggioramento della dispnea o mancato miglioramento della tosse. In caso di dispnea marcata o dolore toracico importante, accesso urgente.

Caso B Accesso in pronto soccorso con dimissione

Uomo, 64 anni | Episodio indipendente dal caso A

B1 Verbale di pronto soccorso

Ingresso 17/09/2026 ore 10:10 | Dimissione ore 13:35 | Estensore: medico di PS

Motivo di accesso e storia: Capogiro all'alzarsi in piedi dalla mattina, senza perdita di coscienza. Due giorni di scariche diarroiche, risolte dalla sera precedente, con ridotto introito di liquidi. Nega dolore toracico, dispnea, palpitazioni e deficit neurologici.

Valutazione iniziale: Ore 10:17: PA 124/78 mmHg supino, FC 80/min, T 36,7 °C, SpO₂ 98% in aria ambiente. Ore 10:33: PA 103/66 mmHg in ortostatismo con riproduzione del capogiro. Stato di coscienza normale, linguaggio e forza conservati, deambulazione autonoma. Mucose lievemente asciutte; addome trattabile e non dolente.

Accertamenti: Glicemia capillare 96 mg/dL. ECG delle 10:50: ritmo sinusale 78/min, senza alterazioni ischemiche acute. Non sono stati richiesti esami ematici in questo accesso dopo la valutazione clinica.

Intervento ed evoluzione: Osservazione e reidratazione orale. Alle 12:55 il paziente è asintomatico in ortostatismo, PA 118/72 mmHg in piedi, deambula senza capogiro.

Valutazione conclusiva e istruzioni: Presincope verosimilmente associata a ridotto introito idrico dopo gastroenterite, con sintomi ortostatici risolti durante osservazione. Dimissione a domicilio. Si raccomandano idratazione regolare e contatto con il MMG se i sintomi ricompaiono; nuovo accesso urgente in caso di sincope, dolore toracico, dispnea o sintomi neurologici.

Caso C Visita diabetologica ambulatoriale

Donna, 68 anni | Episodio indipendente dai casi A e B

C1 Referto di visita diabetologica

Visita 22/09/2026 ore 10:40 | Referto validato ore 11:20 | Destinatari: paziente e MMG

Motivo e intervallo dall'ultima visita: Controllo programmato di diabete mellito tipo 2, diagnosticato circa 8 anni fa. Riferisce assunzione regolare dei farmaci negli ultimi mesi e nessun episodio di ipoglicemia sintomatica. Nessuna nuova complicanza riferita.

Terapia all'ingresso: Metformina 1.000 mg per os a colazione e cena; empagliflozin 10 mg per os al mattino. Non assume insulina o sulfaniluree.

Dati disponibili e visita: HbA1c del 15/09: 7,4% (57 mmol/mol), precedente 8,2% sei mesi prima. Creatinina 0,91 mg/dL, eGFR 71 mL/min/1,73 m², rapporto albumina/creatinina urinaria 18 mg/g. PA 132/78 mmHg, peso 78 kg, BMI 29,4 kg/m². Piedi: cute integra, sensibilità protettiva conservata al monofilamento. Ultima visita oculistica documentata nel 2025.

Valutazione: Controllo glicemico migliorato rispetto alla visita precedente. Concordato un obiettivo di HbA1c intorno al 7–7,5%, da rivedere in relazione a salute generale, preferenze ed eventuali effetti avversi. Nessuna ipoglicemia riferita.

Terapia e indicazioni: Confermare metformina 1.000 mg due volte al giorno con i pasti ed empagliflozin 10 mg al mattino. Discussi idratazione e gestione temporanea della terapia durante malattia acuta secondo le indicazioni personalizzate già condivise con il curante; la paziente porterà l'elenco aggiornato dei farmaci alla prossima visita.

Follow-up: Ripetere HbA1c e creatinina prima del controllo diabetologico tra circa quattro mesi (gennaio 2027); rapporto albumina/creatinina urinaria al controllo annuale. Prenotare la visita oculistica periodica nel 2026 tramite il percorso abituale. Contattare il MMG in caso di effetti avversi o comparsa di sintomi.

Spunti per la didattica attiva

1. Ricostruite una linea del tempo del caso A distinguendo osservazioni, richieste di esami, risultati, decisioni, somministrazioni e comunicazioni alla dimissione.
2. In quale documento si trova la prima evidenza della sospensione del ramipril? Quale documento permette di verificare la ripresa e la somministrazione?
3. Quali informazioni del caso A sono state prodotte in PS e quali sono state aggiunte dal reparto? Individuate un'informazione riferita dalla paziente e una misurata direttamente.
4. Confrontate i casi B e C: dove sono registrati l'esito dell'accesso e i controlli futuri? Una visita oculistica "da prenotare" può essere considerata eseguita?